جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ايمان حسن انور حسن
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** حلوان **العنوان :** منشيه عين حلوان
رقم البطاقة : 28603122501363 **رقم التليفون :** 01113665461 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 12-03-1986 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ايمان حسن انور حسن
National ID: 28603122501363

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



National ID – Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



National ID – Back
[[DOCTYPE::ID_BACK]]

BAHEYA

بهية

PATIENT NAME: EMAN HASSAN ANWAR HASSAN
GENDER: Female
DATE : 28-Feb-2024 12:17 PM

PATIENT ID: 10124239372
AGE: 37 y
ORDER: 2746105

Report:

99MTC-MDP BONE SCAN

Desired Information: -
skeletal survey.

Technique:
Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99m Tc-MDP in the following manner;

Report:

No hot spot that account for osseous deposits could be detected allover the surveyed skeleton.
Degenerative changes are seen over dorso-lumbar vertebrae.
Arthritic changes are seen over both knees.
Both kidneys are normally visualized.

Conclusion:

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Reported By,

Prof. Huda Fathy, Nuclear Medicine Consultant 02-Mar-2024 01:26 PM

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Patient Name	: [illegible] حسن انور	Request No.	: 13003147
Patient No.	: 474-2024	Request Date	: 24/09/2024
Path No.	: 3604/24	Verification Date	: 10/10/2024
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - تغطية الدولة
Age	: 37 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.
Nature Specimen: Left WLE and axillary lymph nodes.

Gross Examination:
* Left WLE measured 8x3.5x3cm with covering skin ellipse measured 7x3 cm.
* Tumor extent: An ill-defined rubbery greyish white tumor bed site.
* Size: 4 x3 x2cm.
* Skin involvement: Unremarkable grossly.
* Distance from margins: 0.1 cm away from deep margin.
* Axilla: Fibrofatty tissue measured 7x4.5x2.5 cm entangling 14 Lymph nodes up to 1.5x1 cm.

Microscopic Examination:
* Histological Type: Total tumor regression in a case previously diagnosed as invasive duct carcinoma, grade III .
* Ductal carcinoma in situ: Not detected.
* Lymph node involvement: 0/14
* Resection Margins: Free
* Histologic response to therapy: Complete pathological response.
* Microcalcifications: Not detected.

Diagnosis:
Left breast cancer post NACT, WLE and axillary lymph nodes.:
-Total tumor regression in a case previously diagnosed as invasive duct carcinoma, grade III.
- Free resection margins.
- Free LNS (0/14)
- Complete pathological response.

Verified by :
DR.Nermeen Mohammed

غرفة رقم (4) الدور الأول - مبنى رقم (987) - شريف النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: [illegible] / امان حسن انور	Request No.	: 13003147
Patient No.	: 474-2024	Request Date	: 24/09/2024
Path No.	: 3604/24	Verification Date	: 10/10/2024
Sex	: Female	Financial Category	: برنامج دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 37 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- Stage: ypT0, ypN0.

Signature
Prof. Dr.Marwa Mahmoud
Dr.Nermin Mohamed

Verified by :
DR.Nermeen Mohammed

غرفة رقم (4) الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	[illegible]	Request No.	13002988
Patient No.	2[illegible]	Request Date	29/01/2024
Path No.	419/24	Verification Date	11/02/2024
Sex	Female	Financial Category	[illegible]
Age	37 Y	Department	[illegible] Patient
Referreing Doc.		Registered by	marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense and < 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Rana Fathy
Dr. Heba Hasan

Verified by :

CAP Rec[illegible]

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
إدارة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Eman Hassan Anwar Hassan	Date: 12/02/2024
Exam : C.T ABDOMEN &PELVIS	Age : 38 Year(s)
Medical ID: 474/2024	

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. ***Chest:***

- Left breast UOQ irregular speculated mass lesion measuring 4.3 X 2.2 cm.
- Left axillary level I and II enlarged lymph nodes the largest measures 1.6 X 1 cm.
- Enlarged left internal mammary lymph node seen measuring 1 X 1.5 cm.
- No sizable pulmonary nodules.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. ***Abdomen and pelvis:***

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- IUD is seen.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. ***The scanned skeleton:***

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
الهيئة العامة للمراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Eman Hassan Anwar Hassan	Date: 12/02/2024
Exam : C.T ABDOMEN &PELVIS	Age: 38 Year(s)
Medical ID: 474/2024	

- Subtle L2 and D9 lytic lesions are noted the largest is the former measuring 1.5 cm.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- ***Left** breast malignant looking mass lesion with pathological ipsilateral axillary and internal mammary lymph nodes as described.*
- ***Few** osseous lesions as described for bone scan.*
- ***No** definite hepatic or pulmonary metastatic deposits.*

Dr.Mohammed Mohsen, MSc.

Dr. Ola Magdy, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Eman Hassan Anwar Hassan	Date : 22/01/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 37 Year(s)
Medical ID: 28603122501363	Pat. ID: 46280

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Left palpable lump felt few days ago

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO views DBT (Digital Breast Tomosynthesis).
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left UOQ obscured lesion of moderate density seen 5.6 cm from the nipple. US showed 2:00 ill-defined hypoechoic solid lesion with microlobulated outline measuring 2.4x2.1x3.7 cm seen 0.66 cm from the overlying skin. Another near by similar smaller lesion measuring 0.74x0.34 cm
- Left UOQ IMLN. US showed 2:00 enlarged IMLN measuring 0.9x0.5 cm showing diffuse cortical thickening and muffled hilum, seen 0.86 cm from the index lesion
- No right suspicious mass lesions, suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- Complementary ultrasound showed no right solid or cystic mass lesions.
- Normal skin thickness and nipple areola complex.
- Bilateral non-specific axillary LNs

Opinion:

- Normal right breast study (BIRADS 1)
- Left UOQ two adjacent suspicious solid lesions with ipsilateral indeterminate IMLN. For Histopathological correlation (BIRADS 4)

Yours truly

Signature Dr. Yasmin Nada

22/01/2024 11:20 AM

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]